

만성통증 환자의 불안정애착이 대인관계 문제에 미치는 영향*

박 유 리**, 정 셋 별***
노 수 림****, 김 영 훈*****
조 성 근*****

〈 목 차 〉

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 1. 서 론 | 3. 연구 결과 |
| 2. 연구방법 | 1) 측정변인들의 평균 및 표준편차
및 상관계수 |
| 1) 연구대상 | 2) 불안정애착이 대인관계 문제에
미치는 영향 |
| 2) 측정도구 | 3) 집단과 모호한 얼굴표정 종류에
따른 부정적 반응편향 |
| 3) 연구절차 | |
| 4) 자료준비 | 4. 논 의 |
| 5) 자료분석 | |

초 록

본 연구는 불안정애착이 만성통증 환자의 대인관계 문제를 예측하는데 있어 주요 요인으로 알려진 통증과국화와 비교해 상대적 예측력을 비교하고, 불안정애착 차원에 따른 모호한 얼굴표정에 대한 부정적 편향을 살펴보고자 하였다. 본 연구를 위해 대한민국 서울 소재 대학병원 통증센터에서 치료를 받고 있는 환자 46명을 모집하였다. 분석결과, 불안애착은 만성통증 환자의 대인관계 문제를 유의하게 예측했고, 통증과국화보다 더 큰 예측력을 보였다. 또한 불안애착이 높은 집단이 불안애착이 낮은 집단에 비해 모호한 얼굴표정 종류에 상관없이 더 부정적으로 인식한 반면, 회피애착의 경우 집단 간 차이가 없었다. 본 연구의 결과는 불안애착의 특성이 타인의 정서적 반응에 대한 부정적 인식을 통해 만성통증 환자의 대인관계 문제에 영향을 미칠 수도 있음을 시사한다.

주제어: 만성통증, 불안정애착, 통증과국화, 대인관계 문제, 얼굴표정

* 이 논문 또는 저서는 2013년 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2013S1A5A2A01019916).

** 충남대학교 석사(pyr5241@naver.com) (제1저자)

*** 충남대학교 석사과정(dkrkquf92@hanmail.net) (공동저자)

**** 충남대학교 심리학과 조교수(srnoh@cnu.ac.kr) (공동저자)

***** 가톨릭대학교 의과대학 서울성모병원 마취통증의학과 조교수(anekeyh@catholic.ac.kr) (공동저자)

***** 충남대학교 심리학과 조교수(sungkunc@cnu.ac.kr) (교신저자)

■ 최초투고일 : 2016년 4월 9일 ■ 심사마감일 : 2016년 4월 21일 ■ 게재확정일 : 2016년 7월 5일

1. 서론

만성통증이란 일반적으로 통증이 3-6개월 이상 지속되며, 예상한 치료기간을 넘고 통증의 범위와 존재를 설명하기에 불충분한 경우를 말한다(Turk & Okifuji, 2001). 국내의 경우 2006년 141만 명이던 만성통증 환자가 최근에는 250만 명으로 증가했다(대한통증학회, 2011). 이러한 만성통증은 수면 장애, 식욕과 체중의 변화, 성욕 감퇴, 집중력 저하 등 여러 기능적 활동에 제약을 일으킨다(이은옥 외, 1996). 또한 만성통증 환자들은 통증으로 인해 결근, 불완전 고용, 실직 등의 사회적 고립을 겪고 있어(최순희, 1996) 많은 사회·경제적 비용 손실을 초래하고 있다(한국보건사회연구원, 2001; Gatchel & Okifuji, 2006).

대인관계는 스트레스의 해로운 영향으로부터 보호해주며(Cohen & Wills, 1985), 개인이 위기에서 이용할 수 있는 자원이다(Lin, Ensel, Simeone, & Kuo, 1979). 만성통증 환자에게 대인관계는 '통증'이라는 위기에 있어서 통증을 경감시키거나 일상생활을 유지해나가는 데 중요한 자원이다. 그러나 만성통증 환자의 경우 만성통증으로 인해 다른 사람들과 만나는 것을 부담스럽게 느끼며, 주위의 가족이나 가까운 이웃이 있어도 이들과는 다른 삶을 살고 있다고 생각하여 늘 혼자라고 생각한다(양진향, 2005). 또한 만성통증 환자의 가족들은 환자의 통증이 만성화될수록 스트레스 수준이 증가하여 환자와 갈등을 경험하게 된다(Keefe, et al., 2003; Snelling, 1994). 이러한 대인관계 문제와 사회적 고립은 만성통증 환자들에게 정신적인 스트레스로 작용하여 만성통증의 호전을 방해하고 증상을 악화시키며(박진우, 2009) 자살에도 영향을 미치는 것으로 보고되었다(김연정 · 이광자, 2010). 따라서 만성통증 환자들이 겪고 있는 통증이 더 악화되는 것을 예방하고 환자들이 통증에 적응하게 하기 위해서는 이들의 대인관계 문제에 대한 이해가 필요하다.

이와 관련하여 선행연구들은 만성통증 환자의 대인관계 과정에서 문제를 발생시키며, 가족 관계 및 치료자와의 관계를 악화시키는 주요 요인으로 통증과국화를 제시했다(Lackner & Gurtman, 2004; Keefe, et al., 2003). 통증과국화란 예상된 통증이나 실제적인 통증을 경험하는 동안에 발생하는 과장된 부정적 정신과정으로 통증경험의 중요한 예측요인들 중 하나이다(Sullivan, et al., 2001). 전통적인 모델들은 만성통증 환자들이 신체적 고통을 감소시키기 위한 대응전략으로 통증과국화를 사용한다고 설명했다(Vlaeyen & Linton, 2000). 그러나 최근 Communal Coping Model(CCM; Sullivan, et al., 2001)에서는 통증과국화를 대인관계 대처전략으로 바라보며 만성통증 환자들이 대인관계 상황에서 타인의 지지나 공감, 혹은 사회적 접근을 얻기 위한 수단으로 사용한다고 제시했다. 이는 통증과국화 수준이 높은 만성통증 환자에게 통증을 줄이는 것 보다 타인으로부터 공감적인 반응을 얻는 것이 더 중요할 수 있음을 시사한다(Sullivan, et al., 2001). 그럼에도 불구하고 이들은 타인과 배우자가 제공하는 반응을 부정적으로 인식하며(Boothby, Thorn, Overduin, & Charles, 2004; Buenaver, Edwards, & Haythornthwaite, 2007) 자신의 돌봄자를 정서적인 지지가 부족한 사람으로서 인식하

는 특징을 보이기도 한다(Keefe, et al., 2003). 이와 같이 통증과국화는 통증에 대처하는 여러 전략들 중 대인관계 문제와 가장 크게 연관되어 있다(Lackner & Gurtman, 2004).

최근 발달적 관점에서는 생애초기에 주양육자와의 상호작용에 의해 형성된 불안정애착(Batholomew & Horowitz, 1991)이 성인기까지 이어져 통증과국화에 영향을 미칠 수 있다고 제안했다(Ciechanowski, Sullivan, Jensen, Romano, & Summers, 2003; Meredith, Strong, & Feeney, 2006, 2007). 불안정 성인애착은 불안애착과 회피애착 두 가지 차원으로 분류된다. 불안애착은 '자신'에 대한 부정적인 내적작동모델을 가진 차원으로 타인에게 정서적으로 집착하며 친밀감에 대한 갈망 등을 나타낸다(Bartholomew & Horowitz, 1991). 반면에 회피애착은 '타인'에 대한 부정적인 내적작동모델을 가진 차원으로 타인의 의도에 대한 의심과 불안이 있으며, 타인과 정서적인 거리를 유지하려한다. 이로 인해 불안애착을 지닌 사람은 주로 대인관계를 유지하는데 어려움을 겪으나, 회피애착을 지닌 사람은 대인관계를 맺는 능력이 부족한 경향이 있다(이정희 · 심혜숙, 2007). 이와 같이 만성통증 환자의 불안애착과 회피애착은 대인관계 문제에 서로 다른 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 차이에 대해 보다 구체적으로 살펴볼 필요가 있다.

원만한 대인관계를 위해서는 타인의 정서를 정확하게 파악하고 이해하는 능력이 필수적이다(Simon, Rosen, Grossman, & Pratoski, 1995). 타인의 정서는 언어적 정보와 몸짓, 목소리, 얼굴표정과 같은 비언어적 정보를 통해 표현되는데(Izard & Malatesta, 1987), 이 중 얼굴표정은 타인의 정서적 상태와 기분, 의사를 전달하는 수단으로 매우 중요하다(Ekman, 1999). 따라서 얼굴표정 인식의 정확성이 떨어지는 경우, 타인의 정서를 잘못 판단할 가능성이 높으며, 이로 인해 대인관계 손상 및 사회적 고립과 같은 사회적 부적응을 경험할 수 있다(남소현, 2010). 이러한 점에서 얼굴표정 인식능력은 불안정애착과 대인관계 문제 간의 관계를 설명하는데 중요한 요인이 될 수 있다. 예를 들면, 불안정애착의 경우 타인의 거부 표현(불안애착) 또는 친밀감의 표현에 대해 공포(회피애착)를 갖고 있어 얼굴 표정을 잘못 인식하게 될 가능성이 높아 타인이 본래 전달하려고 한 의사를 잘못 파악하여 대인관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다(박기라, 2009).

따라서, 본 연구는 만성통증 환자의 불안정애착과 대인관계 문제 간 관련성을 검증하고, 대인관계 문제를 예측하는데 있어 기존에 알려진 주요 요인인 통증과국화와 비교해 불안정애착의 상대적 예측력을 비교하고자 했다. 이와 더불어 추가적으로 불안정애착 차원에 따른 정서가 혼합된 모호한 얼굴 표정에 대한 부정적 편향을 살펴보고자 했다.

2. 연구방법

1) 연구대상

본 연구는 서울 소재 대학병원 통증센터에서 치료를 받고 있는 환자 중 통증기간이 3개월 이상인 환자를 대상으로 실시되었다. 자료는 46명의 환자를 대상으로 수집되었으나 불성실하게 응답한 5명의 자료를 제외한 41명의 자료가 분석에 사용되었다. 전체 41명의 성별은 남자 49%, 여자 51%이며 평균연령은 40세($SD=10.7$)였다. 이들의 통증기간은 중앙값 36개월, 범위 3개월-266개월이었으며 가장 심한 통증부위에 대한 응답으로는 허리(31.7%), 전신(14.6%), 어깨(9.8%), 손(9.8%), 목(7.3%), 기타(26.8%) 순이었다. 이들의 결혼상태는 미혼이 56.1%, 교육수준은 고졸 이상이 95.1%였다.

2) 측정도구

(1) 성인애착

성인애착은 Brennan, Clark와 Shaver(1998)가 개발하고, 김성현(2004)에 의해 번안 및 타당화가 이루어진 한국판 성인애착검사(Experiences in Close Relationship-Revise, ECR-R)로 측정되었다. 이 척도는 불안애착과 회피애착 2요인, 총 36문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 7점 척도로 '전혀 아니다(1점)'에서 '매우 그렇다(7점)'로 이루어져 있으며, 총점의 범위는 각각 18점에서 126점으로 점수가 높을수록 해당 애착의 특성을 더 많이 나타내는 것을 의미한다. 본 연구에서 사용된 한국판 ECR-R의 Chronbach's alpha는 .72였다.

(2) 통증파국화

통증파국화는 Sullivan, Bishop과 Pivik(1995)가 개발하고, Cho, Kim과 Lee(2013)에 의해 번안 및 타당화가 이루어진 한국판 통증파국화 질문지(Pain Catastrophizing Scale: PCS)로 측정되었다. 이 척도는 무력감, 과장, 반추의 3요인, 총 13문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 5점 척도로 '전혀 아니다(0점)'에서 '매우 그렇다(4점)'로 이루어져 있으며, 총점의 범위는 0점에서 52점으로 점수가 높을수록 파국화가 크다는 것을 의미한다. 본 연구에서 사용된 한국판 PCS의 Chronbach's alpha는 .94였다.

(3) 대인관계 문제

대인관계 문제는 한국판 대인관계문제검사 원형척도의 단축형(Short form of the Korean Inventory of Interpersonal Problems Circumflex Scales: KIIP-SC; 홍상황·박은영·김영환·권정혜·조용

래 · 진유경, 2002)으로 측정되었다. 이 척도는 통제지배, 자기중심성, 냉담, 사회적억제, 비주장성, 과순응성, 자기희생, 과관여의 8요인, 총 40문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 5점 척도로 '전혀 아니다(1점)'에서 '매우 그렇다(5점)'로 이루어져 있으며, 총점의 범위는 40점에서 200점으로 점수가 높을수록 개인이 대인관계에서 느끼는 어려움이 크다는 것을 의미한다. 본 연구에서 사용된 한국판 KIIP-SC의 Chronbach's alpha는 .94였다.

(4) 실험자극

본 연구에서 사용한 10명의 얼굴표정 자극은 얼굴표정 데이터베이스인 KUFEC(Korea Univ. Facial Expression Collection, 이태호 · 이규용 · 이강희 · 최준식 · 김현택, 2006)에서 예비실험을 통해 선정되었다. 예비실험은 10명의 대학생을 대상으로 44명(20명 남자, 24명 여자)의 얼굴표정에 대한 정서가를 평정하도록 구성되었다. 얼굴표정은 배우별로 4가지 정서(슬픔, 분노, 두려움, 행복)로 구성되어 한 참가자당 총 176개(44명 × 4가지 정서) 자극이 제시되었다. 참가자들은 각 자극에 대해 7점 척도로 '전혀 아니다(0점)'에서 '매우 그렇다(6점)'로 평정하였고 점수가 높을수록 해당 정서를 크게 느끼는 것을 의미한다. 평정 결과, 해당 정서의 정확성이 가장 높게 나온 남자 배우 5명, 여자 배우 5명의 얼굴표정 자극을 선정했다.

선정된 10명의 배우 얼굴표정 자극들은, 얼굴 영상처리 소프트웨어(FantaMorph 4.0, Abrosoft)를 통해 두 가지 다른 기본정서(한 가지는 항상 행복)를 각기 다른 정서혼합 비율(예. 행복70%-분노30%, 행복60%-분노40%, 행복40%-분노60%, 행복30%-분노70%)로 몰핑하여 복합표정자극을 제작했다. 결과적으로 본 연구에서는 3가지 종류의 정서조합(행복-슬픔, 행복-분노, 행복-두려움)과 4가지 종류의 정서조합 비율(70:30, 60:40, 40:60, 30:70)을 사용하여 총 120개의(3가지 정서조합 × 4가지 정서조합 비율 × 10명의 배우) 자극을 사용했다. 모든 자극은 E-prime 2.0 소프트웨어(Psychology Software Tools)를 사용하여 19인치 LCD모니터에 제시되었다.

3) 연구절차

모든 참가자들은 실험에 대한 동의를 한 후, 개별적으로 검사를 진행하기 위해 조용한 방으로 이동했다. 참가자들은 설문지를 작성한 후, 모호한 얼굴표정과제를 수행했다. 과제를 수행하는 방법은 다음과 같이 안내했다. "이 실험은 얼굴표정 사진을 보고 정서를 평가하는 것입니다. 컴퓨터 모니터 중앙에 얼굴표정이 제시되고, 얼굴표정 양 옆에는 번호가 매겨진 두 개의 정서단어가 제시됩니다. 얼굴표정을 보고 두 개의 정서 중 하나의 두드러진 정서가 인식 되었을 때 가능한 한 빨리 1번 혹은 2번 키보드 버튼을 누르시면 됩니다." 얼굴표정 자극은 무선적으로 제시되었고, 참가자가 키보드 버튼을 눌렀을 때 다음 자극으로 넘어갔다. 본 과제는 10번의 연습시행 후 120번의 본 시행으로 구성되었고, 총 과제 소요시간은 약 15분이었다.

4) 자료준비

본 연구에서는 모호한 얼굴표정 인식에 대한 부정적 반응편향을 알아보기 위해 Donaldson(1996)이 제시한 반응편향점수(response-bias score)를 계산했다. 적중(Hit Rate, HR)은 두 가지 정서로 혼합된 얼굴표정에서 우세한 정서의 얼굴표정으로 응답한 것을 의미하며(e.g., 슬픔70% 행복30%로 혼합된 얼굴표정에서 슬픔으로 응답), 오경보(False Alarm, FA)는 두 가지 정서로 혼합된 얼굴표정에서 우세하지 않은 정서의 얼굴표정으로 응답한 것을 의미한다(예, 행복70%, 슬픔30%로 혼합된 얼굴표정에서 슬픔으로 응답). 반응편향점수(B''_D)를 계산하기 위한 수식은 다음과 같다.

$$B''_D = [(1-HR)(1-FA) - (HR)(FA)] / [(1-HR)(1-FA) + (HR)(FA)]$$

한 개 정서 쌍에서 두 개의 반응편향점수가 산출되지만(예, 행복-슬픔: 행복에 대한 반응편향점수, 슬픔에 대한 반응편향점수), 본 연구에서는 부정적 반응편향점수(슬픔, 분노, 두려움)만을 사용하였다. 반응편향점수의 범위는 -1에서 +1로 (+)점수는 부정적 반응에 대해 보수적인(conservative) 경향을 의미한다. 즉, 부정적인 정서가 긍정적인 정서에 비해 우세하든지 열세하든지 상관없이 긍정적인 정서로 반응하는 것을 의미(예, 슬픔70%, 행복30%일 때 행복으로 반응)한다. (-)점수는 부정적인 반응에 대해 개방적인(liberal) 경향을 의미하는 것으로 부정적인 정서가 긍정적인 정서에 비해 우세하든지 열세하든지 상관없이 부정적인 정서로 반응하는 것을 의미(예, 슬픔30%, 행복70%일 때 슬픔으로 반응)한다.

5) 자료분석

수집된 자료는 SPSS 21.0을 이용하여 분석했다. 변인들 간의 관계를 살펴보기 위해 Pearson 상관분석을 실시했으며 불안정애착이 만성통증 환자의 대인관계 문제에 미치는 영향을 살펴보기 위해 위계적 회귀분석(hierarchical regression analysis)을 실시했다. 추가적으로 불안정애착 차원에 따른 모호한 얼굴표정 인식의 부정적 반응편향점수를 비교하기 위해 2(집단: 고-불안애착, 저-불안애착 or 고-회피애착, 저-회피애착) × 3(얼굴표정 종류: 행복-분노, 행복-슬픔, 행복-두려움) 반복측정 ANOVA를 수행했다.

3. 연구 결과

1) 측정변인들의 평균 및 표준편차 및 상관계수

만성통증 환자의 통증과국화와 불안정 애착 및 대인관계 문제 간의 관계를 살펴보기 위해 Pearson 상관분석을 수행했다. 변인들 간의 평균, 표준편차 및 상관계수는 <표 1>에 제시했다. 변인들 간의 상관을 살펴본 결과, 통증과국화와 대인관계 문제 간의 상관($r=.75, p<.01$), 불안애착과 대인관계 문제 간의 상관($r=.82, p<.01$) 및 회피애착과 대인관계 문제 간의 상관($r=.67, p<.01$)이 높게 나타났다.

<표 1> 측정변인들의 평균, 표준편차 및 상관계수(N=41)

		M(SD)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	연령	40 (10.70)	-							
2	성별	1.51 (0.51)	-.14	-						
3	통증기간	49.98 (52.40)	.23	-.27	-					
4	통증강도	5.32 (2.05)	-.03	-.09	.32*	-				
5	통증과국화	27.22 (14.30)	.04	.05	.05	.55***	-			
6	불안애착	58.80 (20.34)	.05	.01	-.20	.46**	.63***	-		
7	회피애착	70.02 (18.45)	.00	-.10	-.07	.44*	.60***	.63***	-	
8	대인관계	98.21 (27.32)	.14	.08	-.18	.49**	.75***	.82***	.67***	-

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

2) 불안정애착이 대인관계 문제에 미치는 영향

본 연구에서는 불안정애착의 두 차원인 불안애착과 회피애착이 만성통증 환자의 대인관계 문제에 추가적인 설명량을 지니는지 살펴보기 위해 위계적 회귀분석을 실시했다. 회귀모형에서 만성통증 환자의 인구사회학적 특성(성별, 나이, 통증기간), 통증강도, 통증과국화를 1, 2, 3단계에 각각 투입했고, 4단계에서는 불안정애착의 각 차원을 투입했다. 그 결과는 <표 2>와 같다. 먼저, 자료에

대한 다중공선성(multicollinearity)을 확인한 결과, 모든 변인에서 공차한계(tolerance)가 .1보다 크고, 분산팽창계수(variance inflation factor: VIF)가 10보다 작으므로 다중공선성의 문제는 없는 것으로 나타났다. 회귀모형은 1단계를 제외하고 모두 유의했다($p < .001$). 만성통증 환자의 인구사회학적 특성에 의해 설명되는 변량은 8.0%($\Delta R^2 = .08$, $p = n.s.$), 통증강도에 의해 추가로 설명되는 변량은 36.0%($\Delta R^2 = .36$, $p < .001$), 통증과국화에 의해 추가로 설명되는 변량은 24.0%($\Delta R^2 = .24$, $p < .001$), 불안정애착에 의해 설명되는 변량은 13.0%($\Delta R^2 = .13$, $p < .001$)로 나타났다. 또한 통증과국화($\beta = .32$, $p < .01$)와 불안정애착 중 불안애착($\beta = .45$, $p < .001$)의 표준회귀계수가 회귀모형에서 유의한 영향력을 가진 것으로 나타났다. 그러나 회피애착($\beta = .14$, $p = n.s.$)의 표준회귀계수는 회귀모형에서 유의한 영향력을 가지지 않은 것으로 나타났다.

〈표 2〉 대인관계 문제에 대한 위계적 회귀분석 결과

단계	예측변인	β (최종)	ΔR^2	R^2
1	성별	.07		
	연령	.15		
	통증기간	-.14	.08***	
2	통증강도	.10	.36***	
3	통증과국화	.32**	.24***	
4	불안애착	.45***		
	회피애착	.14	.13***	.81***

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

3) 집단과 모호한 얼굴표정 종류에 따른 부정적 반응편향

집단과 모호한 얼굴표정 종류에 따른 부정적 반응편향을 비교하기 위해 2(집단: 고-불안애착, 저-불안애착 or 고-회피애착, 저-회피애착) $\times$ 3(얼굴표정 종류: 행복-분노, 행복-슬픔, 행복-두려움) 반복 측정 ANOVA를 수행했다. 그 결과 불안애착의 경우 집단에 따른 주효과($F(1, 39) = 6.44$, $p < .05$)는 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 모호한 얼굴표정의 종류와 상관없이 고-불안애착 집단($M = -.72$, $SE = .12$)은 저-불안애착 집단($M = -.29$, $SE = .12$)보다 모호한 얼굴표정을 더 부정적으로 인식했다는 것을 의미한다. 얼굴표정의 종류에 따른 주효과($F(1, 39) = 2.88$, $p = .06$)는 유의한 경향성(marginally significance)이 나타났으나, Bonferroni 사후검증 결과 통계적으로 유의하지 않았다. 또한 집단과 얼굴표정 종류에 따른 상호작용 효과($F(2, 39) = .16$, $p = n.s.$)도 유의하게 나타나지 않았다(〈표 3〉 참조). 회피애착의 경우 얼굴표정의 종류에 따른 주효과($F(1, 39) = 2.88$, $p = .06$)는 유의한 경향성(marginally significance)이 나타났으나, Bonferroni 사후검증 결과 통계적으로 유의하지 않았다. 또한 집단에 따른 주효과($F(1, 39) = 2.33$, $p = n.s.$)와 집단과 얼굴표정 종류에 따른 상호작용 효과($F(2, 39) = .12$, $p = n.s.$)도 나타나지 않았다(〈표 3〉 참조).

〈표 3〉 불안애착의 집단과 모호한 얼굴표정 종류에 따른 부정적 반응편향

		df	평균 제곱	F	p
부정적 편향	집단	1	5.61	6.44	.02*
	얼굴표정	2	.20	2.88	.06
	집단×얼굴표정	2	.01	.16	.85

* $p < .05$

4. 논 의

본 연구는 만성통증 환자의 불안정애착과 대인관계 문제 간 관련성을 검증하고, 대인관계 문제를 예측하는데 있어 기존에 알려진 주요 요인인 통증과국화와 비교해 불안정애착의 상대적 예측력을 비교하고자 했다. 이와 더불어 추가적으로 불안정애착 차원(불안애착, 회피애착)에 따른 정서가 혼합된 모호한 얼굴표정에 대한 부정적 편향을 살펴보고자 했다. 본 연구에서 나타난 주요 결과와 논의는 다음과 같다.

첫째, 위계적 회귀분석을 통해 통증과국화는 인구사회학적 특성, 통증강도를 통제하고도 유의한 추가적인 설명량을 나타냈다. 이는 선행연구(Lackner & Gurtman, 2004)와 일치하는 결과로, 통증과국화 수준이 높을수록 더 많은 대인관계 갈등을 경험한다는 것을 의미한다. CCM에 따르면 만성통증 환자들이 타인의 공감과 관심을 이끌어내며 도움을 얻기 위해 통증과국화를 사용한다고 했다(Sullivan, et al., 2001). 그러나 타인에게 지지를 요구하는 태도는 오히려 상대방으로 하여금 자신의 도움 행동이 자발적인 것이 아니라 강요된 것이라고 지각하게 만들어 환자의 통증에 대한 (과장된) 호소를 무시하거나 비난하는 반응으로 이끌 수 있다(Cano, Leong, Heller, & Lutz, 2009).

둘째, 위계적 회귀분석을 통해 불안정애착은 인구사회학적 특성, 통증강도, 통증과국화를 통제하고도 유의한 추가적인 설명량을 나타냈고, 이 중 불안애착이 만성통증 환자의 대인관계 문제를 유의하게 예측했다. 이는 선행연구(Wei, Vogel, Ku, & Zakalik, 2005; 황수민, 2010; 박영주, 2005)와 일치하는 결과로 불안애착 수준이 높을수록 만성통증 환자들이 대인관계 문제를 많이 보인다는 것을 의미한다. 자신에 대해 부정적 내적작동모델을 가진 불안애착(Pietromonaco & Barrett, 2000)의 만성통증 환자들은 타인의 인정과 애정에 과도하게 집착하며, 거부와 버려짐에 대한 공포를 갖고 있어 통증상황에서 반추적이고 정서중심적인 반응을 보일 수 있다. 그러나 이러한 지나친 과민함과 과잉반응을 지속적으로 보일 경우, 타인은 서서히 지쳐 만성통증 환자에게 부정적인 행동을 보이며 피하게 되어(Meifen, 2005; 김은화, 2011 재인용) 결과적으로 대인관계 갈등이 나타날 수 있다. 이러한 불안애착의 특성은 CCM에서 통증과국화가 타인의 관심을 얻기 위해 대인관계 대처전략으로 사용된다고 한 주장과 관련이 있다. 선행연구에 따르면, 자신에 대해 부정적인 내적작동모델을 가진 사람들이 타인의 지지를 얻기 위해 자신의 고통을 과장하여 통증과국화를 많이 사용한다고 보고했다(McWilliams

& Asmundson, 2007). 또한 불안애착 수준이 낮은 사람들은 타인에게 솔직하게 도움을 요청하는 적응적인 방법을 사용하는 반면, 불안애착 수준이 높은 사람들은 통증행동을 보이며 파괴적인 생각을 표현하는 부적응적인 방법을 사용했다(McWilliams & Holmberg, 2010).

셋째, 불안애착($\beta = .45, p < .001$)은 통증파국화($\beta = .32, p < .01$)와 함께 만성통증 환자의 대인관계 문제를 예측하는 주요 변인이고, 더 나아가 통증파국화 보다 대인관계 문제에 더 큰 영향력을 가진 것으로 나타났다. 이러한 결과는 통증사건 이전에 어릴 적 양육환경 속에서 형성된 불안애착이 만성통증 환자의 대인관계 문제에 대한 취약성 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다.

넷째, 불안애착이 높은 집단이 불안애착이 낮은 집단에 비해 정서가 혼합된 모호한 얼굴표정 종류에 상관없이 더 부정적으로 인식했다. 반면 회피애착의 경우 정서가 혼합된 모호한 얼굴표정에 대한 부정적 편향은 집단 간 차이가 없었다. 이는 불안애착이 분노표정에서만 영향을 미친다는 것으로 보고한 일부 선행연구들(Magai, et al., 1995; 박기라, 2009)과는 다른 결과이다. 이러한 차이는 얼굴표정 인식에 대한 측정치와 관계가 있을 수 있다. 선행연구에서는 얼굴표정에 대한 정확성을 평가한(Magai, et al., 1995; 박기라, 2009) 반면, 본 연구에서는 신호탐지이론에 근거한 반응편향점수를 통해 얼굴표정에 대한 부정적 반응편향을 평가했다. 신호탐지이론은 신호의 탐지가 신호에 대한 관찰자의 정확성(민감도)과 반응기준에 달려있다는 이론으로 어떤 불확실한 상황에서 결정을 내리는 방법을 연구하는데 쓰이고 있다(Christopher & Justin, 2003). 이론에 따르면 정확성 측정치는 자극 속성의 영향을 받는 반면 반응 편향치는 자극 속성의 영향을 받지 않는 측정치이기 때문에(Macmillan & Creelman, 2010) 반응편향은 제시되는 자극과 관계없이 응답자가 보유한 고유특성을 살펴볼 수 있는 신뢰로운 측정치로 볼 수 있다.

본 연구의 결과를 살펴보면 불안애착 수준이 높은 만성통증 환자의 경우 타인의 정서적 반응을 더 부정적으로 인식하는 것으로 나타났다. 불안애착 수준이 높은 사람은 보통 거절당하는 것에 대한 두려움이 커(Feeney & Kirkpatrick, 1996; Fraley & Shaver, 1997), 정서적 반응에 민감하며(Brennan, et al., 1998) 정서를 강하게 경험하게 된다(Searle & Meara, 1999). 이들의 이러한 특징은 정서자극에 대해 과도한 반응을 하게 하여 부정적인 감정을 느낄 가능성을 높인다(Wei, et al., 2005). 따라서 불안애착 수준이 높은 만성통증 환자는 통증상황에서 타인이 제공하는 정서반응(예, 얼굴표정)에 대해 부정적으로 판단하여 부정적인 감정을 느낄 가능성이 높다. 이러한 만성통증 환자의 얼굴표정에 대한 부정적 인식편향은 타인의 의도를 다르게 파악하게 함으로써 타인과의 관계를 유지하는 것을 방해하며 관계를 악화시킬 수 있다.

한편, 회피애착의 경우 만성통증 환자의 대인관계 문제를 유의하게 예측하지 못했고 또한 회피애착의 수준에 따라 타인의 정서적 반응에 대한 부정적 편향의 차이가 없었다. 회피애착 수준이 높은 사람의 경우, 자신과 타인 사이에 거리를 두어 잠재적인 갈등과 거부, 실망을 피하고자 하므로(김은화, 2011) 타인의 관심을 받는 것을 불편해하고(Bowlby, 1980) 자신의 감정이나 표현을 과잉절제하며 관계를 회피한다(Wallin, 2007). 따라서 회피애착 수준이 높은 만성통증 환자는 통증상황에서 타인이 제공하

는 정서적 반응(예, 얼굴표정)에 대해 무관심하며 자신이 느낀 감정에 대해 표현 할 가능성이 적다. 이러한 무관심한 태도는 타인과의 표면적인 갈등을 일으키지는 않지만, 타인과의 관계 형성에 있어서 방해가 되어 고립을 이룰 수 있다. 이와 같이 회피애착은 대인관계를 맺는 능력의 부족으로 호감이 있는 사람에게 다가가는 것의 어려움을 겪는 반면, 불안애착은 타인으로부터 거절과 버림받음의 두려움으로 인해 타인에게 지나치게 민감하여 대인관계를 유지하는 어려움을 겪는다(이정희 · 심혜숙, 2007). 즉, 불안애착은 회피애착과 달리 다른 사람의 존재 여부가 개인의 생활에서 중요한 위치를 차지하며 사회적 상황에서 타인의 평가에 민감하다(김용희, 2014). 따라서 이러한 타인에 무관심한 회피애착의 특성이 만성통증 환자의 대인관계 문제를 유의하게 예측하지 못하게 했고 또한 정서가 혼합된 모호한 얼굴표정 인식에서 차이가 나타나지 않게 한 것으로 보인다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 횡단적 설계를 통한 연구로 결과를 인과적으로 해석하기 어렵다. 둘째, 비언어적인 요소가 다양하나, 본 연구에서는 단지 얼굴표정만을 사용하였기 때문에 이를 전반적인 정서적 반응에 대한 인식으로 해석하는데 한계가 있을 수 있다. 마지막으로 실험자극으로 사용된 얼굴표정은 선행연구에 근거하여 부분적으로 특정한 정서의 얼굴표정과 혼합비율을 선택하여 제작되었기 때문에 얼굴표정이 인위적이며 다양성에 제한이 있을 수 있다. 따라서 후속연구에서는 더 다양한 정서의 얼굴표정과 혼합비율로 제작하여 본 연구 결과와 비교해 볼 필요가 있다.

이와 같은 제한점에도 불구하고 본 연구는 이전까지 만성통증 환자의 대인관계 문제에 영향을 미치는 요인으로 통증과국화가 알려져 있었으나, 불안애착이 보다 더 큰 영향력을 갖으며, 개인의 취약성 요인으로 작용할 수 있음을 확인했다는 점에서 의의가 있다. 특히 본 연구의 결과는 불안애착의 특성이 타인의 정서적 반응에 대한 부정적 인식을 통해 만성통증 환자의 대인관계 문제에 영향을 미칠 수도 있음을 시사한다. 이러한 점을 종합적으로 고려해볼 때, 임상장면에서 불안애착 수준이 높은 만성통증 환자에게 자신의 대인관계적인 두려움을 이해시키고, 주로 사용하고 있는 반추적이고 정서 중심적인 대처방식에 대한 대안을 제시하며, 타인의 정서를 적절하게 인식하며 표현할 수 있는 치료적 개입을 제공하는 것이 도움이 될 수 있다. 또한 불안애착 수준이 높은 만성통증 환자의 대인관계 개선을 위해 만성통증 환자뿐 아니라 보호자에게 만성통증 환자의 애착차원 및 대인관계 방식을 고려한 상호작용 방법을 교육하는 것이 도움이 될 수 있다.

참 고 문 헌

- 김성현 (2004). 친밀 관계 경험 검사 개정판 타당화 연구: 확증적 요인분석과 문항반응 이론을 중심으로. 서울대학교 대학원 석사학위논문 (미간행).
- 김연정 · 이광자 (2010). 유방암과 간암환자의 자살생각, 사회적 지지 및 삶의 의미 간 관계. <Journal of Korean Academy of Nursing>, 40(4), 524-532.

- 김은화 (2011). 성인기 애착의 불안-회피 차원에 따른 대인관계 문제: 스트레스 대처양식의 매개효과 검증. 아주대학교 대학원 석사학위논문 (미간행).
- 남소현 (2010). 우울감이 얼굴표정을 통한 정서 인식에 미치는 영향. 충북대학교 대학원 석사학위논문 (미간행).
- 박기라 (2009). 애착이 얼굴표정 재인의 정확성에 미치는 효과. 고려대학교 대학원 석사학위논문 (미간행).
- 박영주 (2005). 애착의 회피-불안 차원에 따른 우울양식과 대인관계 문제. 가톨릭대학교 대학원 석사학위논문 (미간행).
- 박진우 (2009). <통증클리닉, 내 몸을 살린다>. 서울: 모아북스.
- 양진향 (2005). 만성 요·하지통 환자의 생활세계 경험. <대한간호학회지>, 35(5), 955.
- 이은옥·서문자·김인자·강현숙·김명순·김명자·김영재·김종임·박상연·박인혜·박정숙·배영숙·소희영·송경애·온영·이은남·이인숙·임난영·한정석 (1996). 만성 류마티스 관절염 환자의 자기효능감, 우울 및 일상활동 동과의 관계. <류마티스 건강학회지>, 3(2), 194-208.
- 이정희·심혜숙 (2007). 상담일반: 성인애착이 대인관계에 미치는 영향에 관한 공 변량 구조분석. <상담학연구>, 8(3), 899-915.
- 최순희 (1996). 류마티스 관절염환자의 우울에 대한 사회적 지지기능. <류마티스 건강학회지>, 3(1), 63-89.
- 한국보건사회연구원 (2001). 국민 건강 영양 조사 상병 실태 부분 보고서.
- 홍상황·박은영·김영환·권정혜·조용래·진유경 (2002). 한국형 대인관계문제검 사원형척도의 단축형(KIIP-SC) 구성. <한국심리학회지: 임상>, 21(4), 923-940.
- 황수민 (2010). 부모의 부모애착 및 자녀의 부모애착과 자녀의 대인관계 간의 관계: 남자대학생을 중심으로. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문 (미간행).
- Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), 226.
- Bashore, T. R. (1998). Adult cognition and aging: J. M. Rybash, W. J. Hoyer, and P. A. Rodin. *Clinical Psychology Review*, 8, 122-123.
- Boothby, J. L., Thorn, B. E., Overduin, L. Y., & Charles Ward, L. (2004). Catastrophizing and perceived partner responses to pain. *Pain*, 109(3), 500-506.
- Bowlby, J. (1980). *Attachment and loss: Loss, sadness and depression* (Vol. 3). New York: Basic.
- Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. *Attachment theory and close relationships*, 46-76.
- Buenaver, L. F., Edwards, R. R., & Haythornthwaite, J. A. (2007). Pain-related catastrophizing and perceived social responses: Inter-relationships in the context of chronic pain. *Pain*, 127(3), 234-242.
- Cano, A., Leong, L., Heller, J. B., & Lutz, J. R. (2009). Perceived entitlement to pain-related

- support and pain catastrophizing: Associations with perceived and observed support. *Pain*, 147(1), 249-254.
- Carroll, E. M. A., Kamboj, S. K., Conroy, L., Tookman, A., Williams, A. C. de C., Jones, L., Morgan, C. J. A., & Curran, H. V. (2011). Facial Affect Processing in Patients Receiving Opioid Treatment in Palliative Care: Preferential Processing of Threat in Pain Catastrophizers. *Journal of Pain and Symptom Management*, 41(6), 975-985.
- Cho, S., Kim, H. Y., & Lee, J. H. (2013). Validation of the Korean version of the Pain Catastrophizing Scale in patients with chronic non-cancer pain. *Quality of Life Research*, 22(7), 1767-1772.
- Christopher, D. W., & Justin, G. H. (2003). *Engineering Psychology and Human Performance*: 3rd Edition. 박호완 · 김영진 · 박창호 (역). <공학심리학 제 3판>. 서울: 시그마프레스. (원저 출판연도 1999).
- Ciechanowski, P., Sullivan, M., Jensen, M., Romano, J., & Summers, H. (2003). The relationship of attachment style to depression, catastrophizing and health care utilization in patients with chronic pain. *Pain*, 104(3), 627-637.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98, 310-357.
- Donaldson, W. (1996). The role of decision processes in remembering and knowing. *Memory & Cognition*, 24(4), 523-533.
- Ekman, P. (1999). Basic emotions. In: Dalglish T and Power T (eds) *The handbook of cognition and emotion* (pp. 45-60). New York: Wiley.
- Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (1997). Adult attachment and the suppression of unwanted thoughts. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(5), 1080.
- Feeney, B. C., & Kirkpatrick, L. A. (1996). Effects of adult attachment and presence of romantic partners on physiological responses to stress. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(2), 255.
- Gatchel, R. J., & Okifuji, A. (2006). Evidenced-based scientific data documenting the treatment and cost-effectiveness of comprehensive pain programs for chronic nonmalignant pain. *Journal of Pain*, 7, 779-793.
- Keefe, F. J., Lipkus, I., Lefebvre, J. C., Hurwitz, H., Clipp, E., Smith, J., & Porter, L. (2003). The social context of gastrointestinal cancer pain: A preliminary study examining the relation of patient pain catastrophizing to patient perceptions of social support and caregiver stress and negative responses. *Pain*, 103(1), 151-156.
- Lackner, J. M., & Gurtman, M. B. (2004). Pain catastrophizing and interpersonal problems: A

- circumplex analysis of the communal coping model. *Pain*, 110(3), 597-604.
- Lin, N., Ensel, W. M., Simeone, R. S., & Kuo, W. (1979). Social support, stressful life events, and illness: A model and an empirical test. *Journal of Health and Social Behavior*, 108-119.
- Macmillan, N. A., & Creelman, C. D. (2010). *Detection Theory: A User's Guide 2nd Edition*. 이재식 (역). <신호탐지론 2판>. 서울: 시그마 프레스. (원전 출판연도 2004).
- Magai, C., Distel, N., & Liker, R. (1995). Emotion socialisation, attachment, and patterns of adult emotional traits. *Cognition & Emotion*, 9(5), 461-481.
- McWilliams, L. A., & Asmundson, G. J. (2007). The relationship of adult attachment dimensions to pain-related fear, hypervigilance, and catastrophizing. *Pain*, 127(1), 27-34.
- Meredith, P. J., Strong, J., & Feeney, J. A. (2006). The relationship of adult attachment to emotion, catastrophizing, control, threshold and tolerance, in experimentally-induced pain. *Pain*, 120(1), 44-52.
- Meredith, P. J., Strong, J., & Feeney, J. A. (2007). Adult attachment variables predict depression before and after treatment for chronic pain. *European Journal of Pain*, 11(2), 164-170.
- Pietromonaco, P. R., & Barrett, L. F. (2000). The internal working models concept: What do we really know about the self in relation to others? *Review of General Psychology*, 4(2), 155.
- Searle, B., & Meara, N. M. (1999). Affective dimensions of attachment styles: Exploring self-reported attachment style, gender, and emotional experience among college students. *Journal of Counseling Psychology*, 46(2), 147.
- Snelling, J. (1994). The effect of chronic pain on the family unit. *Journal of Advanced Nursing*, 19(3), 543-551.
- Sullivan, M. J., Bishop, S. R., & Pivik, J. (1995). The pain catastrophizing scale: development and validation. *Psychological Assessment*, 7(4), 524.
- Sullivan, M. J., Thorn, B., Haythornthwaite, J. A., Keefe, F., Martin, M., Bradley, L. A., & Lefebvre, J. C. (2001). Theoretical perspectives on the relation between catastrophizing and pain. *The Clinical Journal of Pain*, 17(1), 52-64.
- Turk, D. C., & Okifuji, A. (2001). Pain terms and taxonomies of pain. In: Loeser, J. D., Butler, S. H., & Chapman, C. R. (Eds.), *Bonica's Management of Pain*. 3rd ed. (pp. 17-25). Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins.
- Wallin, D. J. (2007). *Attachment in psychotherapy*. New York: Guilford.
- Wei, M., Vogel, D. L., Ku, T. Y., & Zakalik, R. A. (2005). Adult Attachment, Affect Regulation, Negative Mood, and Interpersonal Problems: The Mediating Roles of Emotional Reactivity and Emotional Cutoff. *Journal of Counseling Psychology*, 52(1).

The Effect of Insecure Attachment on the Interpersonal Problems in Chronic Pain Patients

Yuri Park

Chungnam National University

Saet Byeol Jeong

Chungnam National University

Soo Rim Noh

Chungnam National University

Young Hoon Kim

Seoul St. Mary's Hospital, College of Medicine, the Catholic University of Korea

Sungkun Cho

Chungnam National University

ABSTRACT

This study examined the effect of insecure attachment on the interpersonal problems in chronic pain patients and perception of ambiguous emotional facial expression according to the dimension of insecure attachment. A total of 46 chronic pain patients seeking treatment in a university pain center located in Seoul, Korea were invited to participate in the study. Results showed that anxious attachment had greatest significant impact on interpersonal problems. Also, chronic pain patients with high anxious attachment perceived ambiguous faces more negatively compared to those with low anxious attachment. The study findings suggest that anxious attachment may affect interpersonal problems in chronic pain patients, through negative perception of emotional facial expression of others.

Keywords: Chronic Pain, Insecure Attachment, Pain Catastrophizing, Interpersonal Problem, Facial Expression